

Kontrola *hiperwentylacji*

Spowolnij oddech, nie pogłębiaj. Za dużo tlenu wygląda jak za mało — paradoks centralny w panice.

CZAS: 5–10 min 2× dziennie + w razie objawów

ŹRÓDŁO: Ley (1985); Clark (1985); Meuret i wsp. (2010, RCT)

JAK UŻYWAĆ

Cel: **wdech 4 s nosem · wydech 6 s ustami · 6–8 oddechów/min** (nie 12–16 jak na co dzień). Powolny, *płytki* oddech, nie głęboki. Trenuj 5 min 2× dziennie — wtedy w ataku ciało odruchowo zwolni. Przy ataku: użyj techniki, ale **NIE** traktuj jej jako „ratunku” — bo wtedy staje się zachowaniem zabezpieczającym.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Szybki oddech wydmuchuje CO₂ — to *hipokapnia*. Spadek CO₂ zwęża naczynia w mózgu (zawroty), zmienia poziom wapnia (mrowienie), daje paradoksalne uczucie duszności mimo nadmiaru tlenu. Meuret i wsp. (2010) w randomizowanym badaniu kontrolowanym (ang. *randomized controlled trial*, RCT) pokazali, że pomiar CO₂ wydechowego (target 35–40 mmHg) redukuje objawy paniki **niezależnie** od pracy poznawczej.

01 ? Jak rozpoznać, że hiperwentyluję

SYGNAŁY ODDECHU

Płytki, klatkowy oddech — unosi się klatka, nie brzuch.

Szybkie tempo — > 12 oddechów/min (norma spokoju to 6–10).

Westchnienia, ziewanie co kilka minut.

Uczucie „nie mogę nabrać powietrza” — choć faktycznie masz go za dużo.

SYGNAŁY CIAŁA (OBJAWY HIPOKAPNII)

Mrowienie palców, ust, policzków.

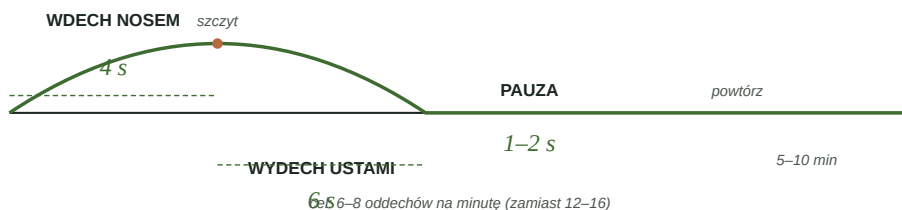
Zawroty, „lekka głowa”.

Nierealność (depersonalizacja, derealizacja).

Skurcze mięśniowe, drżenie.

Jeśli masz ≥ 2 z tych objawów — prawie na pewno hiperwentylujesz.

02 ? Technika 4-6 — oddech docelowy CO₂



POZYCJA I UŁOŻENIE DŁONI

Usiądź lub połóż się. **Lewa dłoń** na brzuchu (1 palec nad pępkiem). **Prawa** na klatce. Cel: *tylko lewa się unosi*. Jeśli unosi się klatka — oddech jest nadal płytki.

CO LICZYĆ I JAK

W myśli liczy „1, 2, 3, 4” na wdechu, „1, 2, 3, 4, 5, 6” na wydechu. *Mniej powietrza, nie więcej.*

Wydech jest dłuższy, bo to on aktywuje przywspółczulny układ nerwowy (ang. *parasympathetic*).

03 ✗ Cztery błędy, które pogarszają stan

BŁĄD 1 · GŁĘBOKIE WDECHY

„Weź głęboki oddech” pogarsza panikę. Im głębszy wdech, tym więcej CO₂ wydychasz, tym silniejsze objawy. *Cel: oddech płytki i wolny, nie głęboki i wolny.*

BŁĄD 2 · ODDYCHANIE DO TORBY

Nie jest rekomendowane. Niesie ryzyko hipoksji (za mało tlenu), trudne do wykonania w panice. Współczesne wytyczne (NICE, APA) tego odradzają. Spowolnij oddech bez akcesoriów.

BŁĄD 3 · TYLKO W ATAKU

Ćwiczenie tylko podczas ataku nie działa. Mózg nie zna wtedy techniki. Trenuj 5 min 2x dziennie w *spokoju* przez 3–4 tyg. — wtedy w ataku ciało odruchowo zwolni.

BŁĄD 4 · ODDECH JAKO RATUNEK

„Tylko oddech mnie uratuje” — to pułapka. Oddychanie staje się *zachowaniem zabezpieczającym* (ang. *safety behavior*), które blokuje ekspozycję interoceptywną i utrwala lęk. Używaj świadomie, jako narzędzie regulacji — nie jako jedynej deski ratunku.

04 📅 Dziennik treningu — 2 tygodnie

Trenuj 2x dziennie w spokoju (rano + wieczór). Po sesji oceń, ile minut udało się ćwiczyć i jaki był efekt. Skala 0–10 PRZED i PO.

DZ.	SESJA <i>rano/wieczór</i>	CZAS <i>min</i>	PRZED <i>0–10</i>	PO <i>0–10</i>	CO ZAUWAŻYŁEM/-AM
<i>Pn</i>					
<i>Wt</i>					
<i>Śr</i>					
<i>Cz</i>					
<i>Pt</i>					
<i>Sb</i>					
<i>Nd</i>					

Klucz: Meuret i wsp. (2010): trening oddechowy z pomiarem CO₂ redukuje objawy paniki o 50–60% w 4 tyg. Ale uważaj — Barlow i wsp. (2000) pokazali, że u *niektórych* pacjentów oddech utrwala schemat „moim ciałem trzeba sterować”. Stosuj jako jedno z narzędzi, nie jako jedyne.